

Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD)

auch Windeldermatitis, Windelausschlag, Windelallergie genannt

Definition: **Eine irritative Kontaktdermatitis**

→ durch Kontakt der Haut mit Urin und Stuhl kommt es zu schmerzhaften Entzündungsprozessen der Haut

Je länger der Kontakt mit der Haut besteht, umso größer ist das Risiko für eine IAD.



Symptome:

- Flächige Rötung (rosa bis hochrot) mit diffusen Rändern zur Hautumgebung
- Schwellung
- Evtl. Blasen mit serösem Exsudat (entzündlich bedingtes, eiweißreiches Sekret, das aus den Kapillaren in das Gewebe oder auf eine Oberfläche austritt)
- Evtl. blutende Areale
- Evtl. oberflächliche Hautdefekte
- Erhöhte Hauttemperatur im Vergleich zur nicht betroffenen Haut
- Evtl. sekundäre Hautinfektion (z.B. Staphylokokken)

Foto IAD Gesäß:



Foto IAD Kleinkind:



Die Hautveränderungen gehen mit Schmerzen einher, sie beeinträchtigen die Lebensqualität.

Entstehung:

- IAD kann bei Patienten in Akutpflegeeinrichtungen **UND** bei Bewohnern von Pflegeheimen auftreten
→ kommt also bei Erwachsenen durchaus häufig vor. (Nicht alle Menschen, die unter Inkontinenz leiden entwickeln eine IAD, es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Gefährdet sind Personen mit:
 - Stuhl- und Doppelinkontinenz
 - Hoher Defäkationsfrequenz von flüssigem Stuhl $\geq 3x/24$ Std.
 - Eingeschränkter Mobilität und/oder Sensorik
 - Schlechtem Gesundheitszustand/Ernährungszustand
 - Trockener, vulnerabler Altershaut (Hautbarriere im Alter geschwächt, Regeneration verlangsamt)
 - Individuellen Hautveränderungen

Der Entstehungsmechanismus einer IAD ist noch nicht vollständig geklärt. Es handelt sich um ein multifaktorielles Geschehen. Folgende Faktoren sind zu nennen:

Hyperhydration: durch zu viel Feuchtigkeit (z.B. Urin/Stuhl, Okklusion durch Hilfsmittel) weicht die oberste Schicht der Epidermis auf und verliert ihre Barriere/Schutzfunktion.

Physikalische Irritationen: feuchtigkeitsgeschädigte Haut ist sehr verletzlich gegenüber Reibung. Sie kann entstehen beim Waschen und Trocknen der Haut, außerdem durch Reibung im Kontakt zu saugenden Hilfsmitteln, zu Kleidung und/oder Sitz- und Liegeflächen.

Chemische Irritationen: Der als Abbauprodukt des Urins entstehende Ammoniak verändert den pH-Wert der Haut von ca. 5 pH (sauer) auf 6–7 pH (alkalisch). Neben diesen pH-Wertveränderungen schädigen zusätzlich Eiweiß- und Fettspaltende Enzyme des Stuhls die Haut. Die Barriere-/Schutzfunktion verringert sich weiter. Auch vermehrte Reinigungsprozeduren spielen eine Rolle.

Biologische Irritationen: Durch die reduzierte Schutzfunktion entsteht eine verminderte Abwehr gegenüber einer pathologischen Keimbesiedlung. Die Gefahr einer möglichen Sekundärinfektion zum Beispiel mit Candida oder Staphylococcus aureus nimmt zu.

Pflegemaßnahmen (auch prophylaktisch)

Prophylaktisch

- Die Ausscheidungen werden abgeleitet, ohne dass Hautkontakt entsteht (z.B. Fäkalkollektor)
- Schutzhosen (müssen regelmäßig gewechselt werden)
- Saugende Hilfsmittel (müssen ebenfalls regelmäßig gewechselt werden)
- Verringerung der Defäkationsfrequenz und der Einwirkungszeit der Ausscheidung auf die Haut
- Schonende Hautreinigung mit lauwarmem Wasser und weichem Lappen (mit ph-neutralen Produkten, KEINE klassische Seife) / zur Rückfettung Wasser-in-Öl-Lotion.
- ! Nach jeder Stuhlausscheidung aber nicht jeder Urinausscheidung
- Hautprotektoren/ Barriersubstanzen

Foto Fäkalkollektor:



Foto Kondomurinal:

